

ACOMPANHAMENTO		CONSULTA	
NS 22231569043		512	
ROSA VIRGINIA NUNES HENRIQUES DOS SANTOS			
IDADE:	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS:			
QUEIXAS:			
MEDICAMENTOS:			
MÉDICO:			
EXERCÍCIO FÍSICO: Hidrog. (2x) / Taiji (2x)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME:		HORA QUE ACORDA:	
COCHILO () SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI:	IAH:	SPO2:
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS			
29/01 - máx. Dreamwear			
loc. CPAP			
05/02 P = 10 med.			
24 IAH = 0,2 e/h			
m. de uso: 6h 11' Dua			
19/02 P = 10 (fixa) amfo Relata estar dormindo s/ CPAP			
24 IAH = 1,8 e/h eee algumas partes da noite			
m. de uso: 4h 33' Oriento sobre ajuste máx. Dua			
06/03/24 P = 10 cmH2O			
IAH = 0,2			
m. de uso: 6h 11m			
fuga: 8,9 (percentil)			
Bem adaptada			
Natasha			
21/03 P = 10 cmH2O			
24 IAH = 0,2			
m. de uso: 6h 7'			
fuga: 6,8 (percentil)			
Bem adaptada			
Natasha			
22/11/24 P = 10 cmH2O			
IAH = 0,2 e/h			
m. de uso: 6 horas			
fuga 7 l/min			
silvia			

28/02/2025

P: 40 cmH₂O
IAH = 0,2 x/h
muro = 6 horas
fuga = 44/min

01/02 01:10
sem dormido tarde

*hoco filtro

silva

23/05
25

P: 10 cmH₂O
IAH = 0,1 x/h
Fuga = 12, lpu

edema na face.

30d / 28d

ana

Formulário de Anamnese (anamnese) com campos para:

- MEDICO
- EXERCICIO FISICO
- HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFE
- HORA QUE DORME
- COCHILHO () SIM () NÃO
- BEBIDA ALCOOLICA () SIM () NÃO
- FUMO () SIM () NÃO
- TIPO DE RESPIRAÇÃO
- CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL
- OVERLAP
- PATÓLOGIAS ASSOCIADAS
- CHIRURGIA: () NASAL () AMIGDALECTOMIA
- INFLAMTAÇÃO DA GARGANTA
- COMORBIDADE: () RESPIRATORIA () ENDOCRINA () CARDIACA () NEUROLÓGICA () OUTROS



CLÍNICA OPUS

OTORRINOLARINGOLOGIA
E ESPECIALIDADES

Rose Virgínia N+1 dos Santos

Relatório Médico

Paciente acima possui apnéia obstrutiva do sono. com $A1H = 5,2$ no polissonografia. Não se adaptou bem ao AIO e tem indicação de CPAP / BiPAP.

CID : G47.3

Renny da Silva Lederer
Otorrinolaringologista
CRM-SP 169378/RQE 6368

24/01/24

Alergia e Imunologia
Cirurgia Plástica da Face
Endocrinologia
Endocrinologia Pediátrica
Fonologia
Otorrinolaringologia
Urologia

Pronto Atendimento Otorrino

www.clinicaopus.com.br

Unidade Jd Nova América:

Rua Fernão Dias, 340 - Jd. Esplanada

CEP: 12242-580 - São José dos Campos-SP

Telefone: (12) 3922-3320 / (12) 3931-0590 / (12) 98703-4312

Nome: ROSA VIRGINIA N. H. DOS SANTOS

Data de Nascimento: 21-9-1960

IMC: 31,62

Sexo: Feminino

Data do exame: 15-03-2018

Peso: 75 kg

Altura: 1,64 m

Médico: DRA. FERNANDA F. VANTINE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-03-2018, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 511,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 65,0 e 144,5 minutos. O tempo total de sono foi de 361,0, eficiência de 70,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,0%; estágio N2: 53,7%; estágio N3: 19,3%; sono REM: 24,0%. O índice de despertares foi de 0,8/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopnéia total foi de 1,7/h, sendo elas 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 10 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 90%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 88 bpm e NREM de 58 - 93 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 1,7/hora;
4. não houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=90%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco a moderado durante o sono.

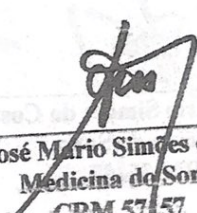
Exame evidenciando roncopia primária.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: ROSA VIRGINIA N. H. DOS SANTOS

Data de Nascimento: 21-9-1960

IMC: 31,62

Sexo: Feminino

Data do exame: 05-07-2017

Peso: 75 kg

Altura: 1,54 m

Médico: DRA FERNANDA F. VANTINE

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 05-07-2017, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 483,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 8,5 e 153,0 minutos. O tempo total de sono foi de 463,0, eficiência de 95,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,2%; estágio N2: 54,0%; estágio N3: 24,3%; sono REM: 20,5%. O índice de despertares foi de 2,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 5,2, sendo 31 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 9 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e mínima de 85%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 64 - 96 bpm e NREM de 66 - 101 bpm. O paciente roncou.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N3 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 5,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=85%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. número de despertares breves normal;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau leve.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157